

Alle um einen autistischen berufstätigen Erwachsenen / eine autistische berufstätige Erwachsene

Der kumulative Leitfaden für das ganze Team um einen autistischen Erwachsenen in Beschäftigung — Familie & Partner:innen, Trainer:innen & Mentor:innen, Übungsleiter:innen/Studio-Leitende, Ärzt:innen & Arbeitsmedizin-Pflegekräfte, Job-Coaches & Betreuungskräfte, Kolleg:innen & Arbeitgebende und Freund:innen. *Ein erweitertes Nachschlagewerk; kombinieren Sie es mit den Einzel-Gegenstücks-Kurzanleitungen.*

Die Kernidee

Autismus bedeutet über den **Monotropismus**, dass sich die Aufmerksamkeit eines Erwachsenen in wenige tiefe, intensive „Tunnel“ einschließt. Im richtigen Job ist dieser Fokus eine echte Superkraft — Tiefe, Verlässlichkeit, Mustererkennung, Ehrlichkeit. In der falschen Umwelt (Großraum-Lärm, ständige Unterbrechung, Büropolitik, vage Erwartungen) treibt es Masking und **autistisches Burnout**, das von gewöhnlichem beruflichem Stress und Depression zu unterscheiden ist. Viele berufstätige autistische Erwachsene — besonders Frauen — wurden erst im Erwachsenenalter erkannt. Welche Rolle Sie auch haben, die Hebel sind dieselben: schützen Sie Fokus, seien Sie klar und vorhersagbar, kommunizieren Sie schriftlich und wörtlich, und nehmen Sie Burnout als das Ernste, Eigenständige, das es ist.

Was in jedem Setting hilft

- **Schützen Sie Fokus und das Spezialinteresse** — strukturieren Sie Arbeit um weniger, tiefere „Tunnel statt Aufgaben“; minimieren Sie Unterbrechungen und Meetings; erlauben Sie Flow-Zeit.
- **Seien Sie klar und explizit** — schriftliche Briefings, definierte Fristen, benannte Erwartungen; sagen Sie die „ungeschriebenen Regeln“.
- **Kommunizieren Sie schriftlich und wörtlich**; erlauben Sie asynchrone Optionen; gewähren Sie Verarbeitungszeit; lesen Sie eine Pause nicht als Widerstand.
- **Senken Sie sensorische und soziale Last** — ruhigere Räume, optionales Soziales, weniger erzwungene Gruppenforderungen.
- **Nehmen Sie Burnout ernst** — chronische Erschöpfung, Kompetenzverlust und verminderte Toleranz brauchen *reduzierte Last und Entmasken*, nicht „Durchziehen“; reasonable Anpassungen, Auszeiten oder ein Rollenwechsel sind Erholung, keine Schwäche.
- **Zentrieren Sie ihre Expertise** — die Person ist die Expertin für das, was hilft; reasonable Anpassungen (Gleichbehandlungsgesetz / ADA) sind ein Recht.

Was Sie in jedem Setting vermeiden sollten

- Vage Briefings, kurzfristige Wechsel, Überraschungs-„kurze Chats“ oder „das solltest du einfach wissen“-Erwartungen.
- Blickkontakt, Smalltalk oder „Sichtbarkeit“ mit Engagement oder Kompetenz gleichsetzen.
- Burnout als Depression oder Faulheit behandeln; die Person zu mehr Masking drängen.

- Eine maskierte, kompetente Stunde mit „gut sein“ gleichsetzen oder „nicht klagen“ mit „nicht leiden“.

Kurzhinweise für jede Person um den Arbeitnehmenden

Familie, Partner:innen & Freund:innen

Glauben und validieren Sie eine späte Erkennung; stützen Sie Anpassungen und Rechte. Nehmen Sie Burnout ernst — reduzierte Anforderungen und Entmasken schlagen „Durchziehen“. Helfen Sie beim Praktischen, wenn darum gebeten; achten Sie die Autonomie, einschließlich eines Rollenwechsels oder reduzierter Stunden.

Trainer:innen & Mentor:innen

Legen Sie Material und Anweisungen schriftlich, im Voraus fest; bieten Sie Alternativen zu erzwungener Gruppenarbeit; eine Anweisung nach der anderen mit Gründen. Spielen Sie Tiefe und Interesse aus; fragen Sie wörtlich nach der Last.

Übungsleiter:innen, Studio- & Vereins-Leitende

Bieten Sie schriftliche Pläne und vorhersagbare Struktur; ein Cue nach dem anderen; achten Sie Kopfhörer, Ruhe und Routine als Regulation. Seien Sie aufmerksam auf Burnout; eine flexible, anforderungsarme Mitgliedschaft hilft durch schwere Phasen.

Ärzt:innen & Arbeitsmedizin-Pflegekräfte

Bieten Sie das AASPIRE *AHAT* und schriftlich-zuerst-Optionen; erkennen Sie **autistisches Burnout** (von Depression zu unterscheiden); vermitteln Sie reasonable Anpassungen. Medikamente niedrig beginnen und langsam titrieren. Untersuchen Sie auf Suizidalität und begleitende ADHD, Angst, Schlaf- und GI-Zustände.

Job-Coaches & Betreuungskräfte

Helfen Sie, reasonable Anpassungen zu artikulieren; strukturieren Sie die Rolle um „Tunnel statt Aufgaben“; seien Sie die vorhersagbare, sichere Nachfrage. Nehmen Sie Burnout ernst und zentrieren Sie ihre Expertise.

Kolleg:innen & Arbeitgebende

Halten Sie Soziales optional und unauffällig; schützen Sie Fokus; geben Sie wörtliches, freundliches Feedback. Machen Sie reasonable Anpassungen zur Routine. Achten Sie auf Burnout und verweisen Sie an Arbeitsmedizin/Mitarbeiter-Unterstützung.

Freund:innen & Peers

Halten Sie Freundschaft unauffällig und optional; sagen Sie, was Sie meinen; verbinden Sie sich über geteiltes Interesse. Wenn sie auszubrennen scheint oder von Hoffnungslosigkeit spricht, verweisen Sie an Hilfe und behalten Sie es nicht für sich.

Wann weitere Hilfe nötig ist

Achten Sie auf **autistisches Burnout** (chronische Erschöpfung, Kompetenzverlust, verminderte Toleranz) — es ist mit **Suizidalität** verknüpft und von gewöhnlichem Arbeitsstress und Depression zu unterscheiden. Behandeln Sie begleitende **ADHD (AuDHD), Angst, Depression, Schlaf- und GI-Zustände** mit autismus-informierten Kliniker:innen. Reasonable Anpassungen, reduzierte Stunden oder Auszeiten sind Erholung, keine Schwäche.

Wenn die Person eine Frau ist

Frauen sind unter der „verlorenen Generation“ spät-diagnostizierter Erwachsener überrepräsentiert und masken am stärksten. Nehmen Sie ein lebenslanges Muster sozialer/sensorischer Unterschiede und privater Erschöpfung über jedes Setting ernst, auch bei einem „leistungsstarken“ Äußeren.

Über diesen Leitfaden

KI-gestützt, abgeleitet aus den Forschungsentwürfen dieses Projekts — der Leitfaden für **Praktiker und Gesundheitsfachleute über die Lebensspanne** (Teil 3.4), der Leitfaden für die **Familie** (Teil 4) und das **Monotropismus**-Dossier. Verwendet identitätsfirst-Sprache. **Information — kein medizinischer Rat und kein diagnostisches Werkzeug.** Passen Sie es an die einzelne Person an.

Schlüsselquellen. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Knight (2021, *Tunnel statt Aufgaben*); Booth (2021, Arbeit & autistische Menschen); Raymaker et al. (2020, Burnout); Mantzalas et al. (2022); Pearson & Rose (2021, Masking); Kelly Mahler (2024); AASPIRE AHAT; Michaud & Harvey (2025). Vollständige Nachweise finden sich in den Quelldossiers.